

○

×

補助診断としては有用であるが、陳旧性結核でも陽性となること、免疫不全患者などでは偽陰性になることなどから解釈には注意を要する。

1

○

×

再治療例、重症例（空洞や粟粒結核など）、初期2ヶ月の治療後も培養陽性の場合などは全治療期間を9ヶ月とすることが検討される。

×

月1回以上の喀痰検査が推奨される。

×

イソニアジドとリファンピシンに耐性の場合は多剤耐性結核と呼ばれる。これに加えてキノロン系抗菌薬およびカナマイシン、アミカシン、カプレオマイシンのいずれかに耐性のものは超多剤耐性結核と呼ばれる。

○

×

最も多いのはMAC (*M. avium* と *M. intracellulare*) である。

×

非結核性抗酸菌は環境中の常在菌であり、感染症法の指定感染症ではない。

×

気管支洗浄液は1回以上陽性であれば有意とする。喀痰培養の場合は2回以上の異なった検体での培養陽性が必要である。

○